

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SCID-5-PD · ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUCTURADA PARA TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders — Patrón oro estandarizado para la evaluación dimensional y categorial de los 10 trastornos de la personalidad

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD)
Nombre en español	Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del DSM-5
Sigla oficial	SCID-5-PD (anteriormente SCID-II)
Autores originales	Michael B. First, Janet B. W. Williams, Lorna Smith Benjamin y Robert L. Spitzer (2015, 2016)
Adaptación hispanohablante	Editorial Médica Panamericana / American Psychiatric Association Publishing (2016)
Año de publicación original	2016 (versión DSM-5 oficial en español)
Constructo primario	Diagnóstico categorial y dimensional de los 10 trastornos de personalidad de los Grupos A, B y C del DSM-5
Formato de administración	Entrevista semiestructurada heteroaplicada precedida opcionalmente por el cuestionario de cribado SCID-5-SPQ
Población diana	Adultos y adolescentes mayores (≥ 18 años, o ≥ 16 si los rasgos son persistentes y desadaptativos)
Tiempo de aplicación	45 a 90 minutos (entrevista completa) o 15 a 30 min (tras cribado previo SCID-5-SPQ)
Régimen de acceso	Instrumento clínico comercial restringido sujeto a cualificación profesional (APA / Panamericana)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del DSM-5** (SCID-5-PD), sucesora directa de la reconocida SCID-II para DSM-IV, es el patrón oro (**gold standard**) internacional para la evaluación clínica y pericial de la patología de la personalidad. Desarrollada por el equipo de investigación de la Universidad de Columbia encabezado por Michael B. First, la entrevista operacionaliza de manera rigurosa y sistemática cada uno de los criterios diagnósticos oficiales de la Sección II del DSM-5.

El marco conceptual subraya la necesidad de diferenciar entre estados psicopatológicos transitorios (síndromes del Eje I como depresión o manía) y patrones persistentes, inflexibles y generalizados de experiencia interna y comportamiento que se remontan al inicio de la adultez o la adolescencia tardía. La SCID-5-PD permite una doble aproximación métrica: 1) **categorial**, verificando el cumplimiento del umbral mínimo de criterios requeridos para asignar diagnósticos formales; y 2) **dimensional**, sumando las puntuaciones de los criterios para obtener un índice de severidad de cada rasgo. Incluye el Cuestionario de Personalidad SCID-5-SPQ (**Screening Personality Questionnaire** de 106 ítems Sí/No) que agiliza drásticamente el proceso evaluativo al explorar solo las áreas positivas.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Grupo / Trastorno DSM-5	N.º Criterios	Umbral Diagn.	Contenido Clínico y Núcleo Psicopatológico
Grupo A (Raros / Excéntricos) • Paranoide • Esquizoide • Esquizotípico	7 criterios 7 criterios 9 criterios	≥ 4 de 7 ≥ 4 de 7 ≥ 5 de 9	Desconfianza y suspicacia; frialdad y desapego relacional; distorsiones cognitivas/perceptivas y excentricidad conductual.
Grupo B (Dramáticos / Emocionales) • Antisocial • Límite (Borderline) • Histriónico • Narcisista	7 crit. (+ cond. < 15) 9 criterios 8 criterios 9 criterios	≥ 3 crit. A + cond. ≥ 5 de 9 ≥ 5 de 8 ≥ 5 de 9	Transgresión social e impulsividad; inestabilidad afectiva, vincular y autoimagen; teatralidad y búsqueda de atención; grandiosidad y falta de empatía.
Grupo C (Ansiosos / Temerosos) • Evitativo • Dependiente • Obsesivo-Compulsivo	7 criterios 8 criterios 8 criterios	≥ 4 de 7 ≥ 5 de 8 ≥ 4 de 8	Inhibición social e hipersensibilidad al rechazo; necesidad de sumisión y apego; perfeccionismo, rigidez y necesidad de control.
Otro Trastorno de Personalidad	Criterios mixtos	Rasgos brales subum-	Trastorno de la personalidad especificado o no especificado con deterioro funcional claro sin cumplir umbral completo.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Concordancia interjueces (Kappa)	Kappa = 0.74 – 0.92	Elevadísima reproducibilidad diagnóstica entre evaluadores entrenados en hospitales de España y Latinoamérica.
Fiabilidad dimensional (Alfa)	Alpha = 0.76 – 0.88	Adecuada consistencia interna para las puntuaciones dimensionales de cada trastorno.
Fiabilidad test-retest	Kappa = 0.65 – 0.81 (1 mes)	Estabilidad temporal sustancial para rasgos de personalidad patológicos en periodos de estabilidad sintomática.
Validez de constructo y criterio	Sensibilidad > 85%, Esp > 80%	Reconocido unánimemente como el patrón de referencia frente a inventarios autoinformados (MCMI-IV, MMPI-2-RF).
Rendimiento del SCID-5-SPQ	Sensibilidad del cribado = 95%	Excelente sensibilidad del cuestionario previo; virtualmente no omite casos reales (bajo índice de falsos negativos).

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación clínica tripartita de cada criterio:**
 - **0 = Ausente o falso:** El rasgo no existe, no alcanza significación o es puramente reactivo a un trastorno del estado de ánimo/sustancias.
 - **1 = Subumbral:** El rasgo está presente de forma leve o esporádica pero no cumple la intensidad, frecuencia o deterioro funcional requerido.
 - **2 = Umbral / Presente:** El criterio clínico se cumple plenamente según el estándar DSM-5 (patrón persistente, inflexible y disfuncional).
- **Diagnóstico Categorical:** Se computan los criterios puntuados con **2**. Si la suma alcanza o supera el umbral mínimo exigido (ver tabla sección 3), se asigna el diagnóstico formal del trastorno de la personalidad correspondiente.
- **Puntuación Dimensional:** Para investigación o monitorización longitudinal, se suman los valores (0, 1 o 2) de todos los criterios de un trastorno, obteniendo un perfil continuo de carga patológica.
- **Criterio de Inflexibilidad y Cronología:** Para puntuar **2**, el clínico debe verificar que el rasgo ha estado presente durante al menos los últimos 5 años y no es consecuencia directa de otra afección médica o trastorno agudo del Eje I.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Criterios Cumplidos	Estratificación Diagnóstica	Implicación Asistencial y Pronóstico Terapéutico
0 a 1 criterio umbral	Rasgo no patológico / Mínimo	Personalidad dentro de límites normales o rasgos adaptativos funcionales sin interferencia vital.
2 a umbral - 1	Rasgos Subumbrales de Personalidad	Presencia de estilo de personalidad disfuncional que genera vulnerabilidad a estrés pero sin configurar trastorno formal.
Cumple umbral exacto (ej. 5/9 en Límite)	Trastorno de la Personalidad Específico	Diagnóstico clínico positivo. Cumple criterios DSM-5. Interferencia notable en el funcionamiento personal, laboral y social.
Múltiples umbrales (≥ 2 trastornos)	Comorbilidad Severa de Personalidad	Patología grave de la personalidad (ej. comorbilidad Límite-Antisocial o Evitativo-Dependiente). Pronóstico complejo, alto uso asistencial.

REGLA DE ORO DE LA ENTREVISTA CLÍNICA (FIRST ET AL., 2016): Un criterio NUNCA debe puntuarse con **2** basándose únicamente en la afirmación del paciente. El evaluador DEBE exigir ejemplos conductuales concretos, reales y recurrentes de la vida cotidiana del sujeto.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Administración del cuestionario de cribado SCID-5-SPQ:

- El paciente responde los 106 ítems en la sala de espera (15-20 min). Solo los ítems contestados como "Sí" serán explorados en la entrevista.

Paso 2: Realización de la entrevista clínica estructurada SCID-5-PD:

- El evaluador indaga los criterios correspondientes a los ítems positivos, solicitando descripciones detalladas ("¿Podría darme un ejemplo de cuándo le ocurrió esto?", "¿Esto le ha causado problemas en el trabajo o con su pareja?").

Paso 3: Formulación diagnóstica integrada y derivación:

- Trastorno Límite de la Personalidad:** Priorizar indicación de Terapia Dialéctica Conductual (DBT) o Terapia Basada en la Mentalización (MBT); elaboración obligatoria de Plan de Seguridad.
- Trastornos del Grupo A:** Psicoeducación familiar, intervenciones adaptativas de baja carga emocional y antipsicóticos a dosis bajas si hay descompensación distorsiva.
- Trastornos del Grupo C:** Terapia Cognitivo-Conductual focalizada en esquemas (Young), asertividad y exposición interaccional.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 29 años, administrativa, derivada a la Unidad de Trastornos de la Personalidad tras repetidas consultas a urgencias por cortes superficiales en antebrazos, rupturas de pareja caóticas y sensación perenne de vacío.

Resultados en SCID-5-PD:

- Cuestionario de cribado previo: 34 ítems positivos (Grupos B y C).
- Evaluación en entrevista SCID-5-PD:**
 - Trastorno Límite de la Personalidad (TLP):** 7 criterios puntuados con 2 (umbral: $\geq 5/9$): esfuerzos frenéticos para evitar abandono (2), relaciones inestables e intensas (2), autoimagen inestable (2), impulsividad en gastos y atracones (2), conductas autolesivas recurrentes (2), inestabilidad afectiva (2) y sentimiento crónico de vacío (2). **DIAGNÓSTICO CONFIRMADO.**
 - Trastorno de la Personalidad Dependiente:** 4 criterios con 2 (subumbral: umbral $\geq 5/8$).
 - Resto de trastornos negativos o con puntuaciones 0.

Plan Asistencial e Impacto: La confirmación del diagnóstico de TLP permitió desestimar el diagnóstico provisional de Trastorno Bipolar tipo II y suspender polifarmacia inadecuada. La paciente fue ingresada en el programa de DBT ambulatoria (grupo semanal de habilidades + terapia individual) y pauta de estabilizador del ánimo. A los 12 meses de tratamiento, los episodios de autolesión remitieron por completo y se redujo la utilización de servicios de urgencias en un 85%.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS CLÍNICAS CRÍTICAS:

- Contaminación sindrómica aguda:** No aplicar la SCID-5-PD durante un episodio depresivo grave, maníaco o psicótico agudo; los pacientes tienden a sobreenfomar patología de rasgos de forma transitoria.
- Riesgo autolítico en TLP:** La presencia del criterio de autolesiones/ suicidio exige evaluación inmediata con escalas específicas (C-SSRS).
- Conducta antisocial grave:** En sujetos con TP Antisocial, contrastar información con registros penales y fuentes colaterales por alta tendencia a la simulación/fabulación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- Trastorno Afectivo Bipolar:** Diferenciar la inestabilidad anímica del TLP (cambios de horas o días reactivos a conflictos) de los episodios maníacos/depresivos autónomos bipolares.
- TDAH en adultos:** La impulsividad del TDAH es cognitiva y ejecutiva motora constante desde la infancia, sin la angustia de abandono ni la disforia profunda del TLP.
- Trastorno por Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C):** Coexistencia frecuente con traumas infantiles que modulan el apego patológico.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

- First, M. B., Williams, J. B. W., Benjamin, L. S., & Spitzer, R. L. (2016). **SCID-5-PD: Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del DSM-5**. Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing / Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- First, M. B., Williams, J. B. W., Karg, R. S., & Spitzer, R. L. (2015). **Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders, Clinical Version (SCID-5-CV)**. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). **Diagnostic and statistical manual of mental disorders** (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Widiger, T. A., & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic categories or dimensions? A question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. *Journal of Abnormal Psychology*, 114(4), 494–504. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.114.4.494>